

Dati della paziente

Cognome e Nome	
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Dispositivo scelto	
Data inserimento	

1. Informazioni su inserimento IUD/IUS

Dopo il colloquio illustrativo dei vari metodi contraccettivi (contraccezione ormonale, pillola, anello vaginale, cerotto contraccettivo, contraccezione meccanica, IUD, profilattico, sterilizzazione chirurgica) e la valutazione anamnestico-clinica, è stato deciso l'inserimento di un dispositivo intrauterino a scopo contraccettivo.

2. Descrizione dei dispositivi

I dispositivi intrauterini (IUD o spirale contraccettiva) sono costituiti di un materiale plastico biologicamente inerte, il polietilene, con aggiunta di un filamento di rame o rame e argento che potenzia l'efficacia. Il rame rilasciato in utero è tossico per l'ovocita e per gli spermatozoi; inoltre determina una reazione da corpo estraneo con modificazioni della mucosa uterina che ostacolano il passaggio degli spermatozoi.

I sistemi intrauterini (IUS) sono costituiti di materiale plastico che rilascia in cavità uterine piccole dosi del progestinico levonorgestrel e possono essere utilizzati in donne che hanno mestruazioni a carattere emorragico.

3. Efficacia

La percentuale di insuccesso è relativamente bassa: 0,5-0,7% nel primo anno per i sistemi intrauterini medicati con levonorgestrel (IUS-LNG) e 0,6-0,8% nel primo anno per le spirali al rame.

4. Possibili complicanze

La reazione vagale è un'evenienza rara, legata alla stimolazione dell'innervazione dell'utero, che può causare riduzione della frequenza cardiaca. La perforazione uterina è descritta con un'incidenza che varia dallo 0,6 all'1,6 ogni 1000 donne/anno.

Il rischio di infezione pelvica (PID) è molto basso, concentrato nei 20 giorni successivi all'inserimento; si raccomanda l'uso del preservativo in tale periodo. Il rischio di gravidanza extrauterina è ridotto rispetto alla popolazione generale, ma qualora il metodo dovesse fallire, la probabilità che la gravidanza sia extrauterina è elevata.

Con gli IUD al rame, nei primi 3 mesi dall'inserimento le mestruazioni potranno essere particolarmente abbondanti e lunghe. L'espulsione o dislocazione del dispositivo è più frequente nei 3 mesi successivi all'inserimento.

5. Raccomandazioni

È raccomandato osservare alcune ore di riposo e astenersi dai rapporti sessuali per i primi 15 giorni. È necessario effettuare il primo controllo ginecologico dopo 4 settimane e, in seguito, almeno 1 volta all'anno.

6. Espressione del consenso**Toscana Diagnostica S.r.l.**

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

TD-SGI-MOD170_00 · Rev. 00 · Consenso IUD/IUS

Dichiaro di aver compreso quanto esposto e:

Scelta	Barrare
Acconsento all'inserimento di IUD/IUS	☐
Non acconsento all'inserimento di IUD/IUS	☐

Ruolo	Firma	Data
Paziente		
Medico		

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.